

图 35-2 肠管壁疝

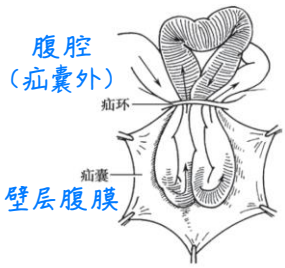
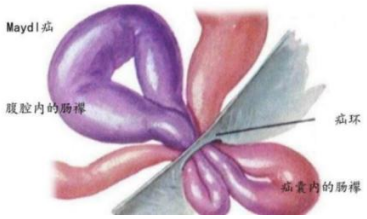


图 35-3 逆行性嵌顿疝



④嵌顿疝处理原则：**多需急症手术复位**；若全满足以下情况可急症手法复位——肠管无绞窄（无腹膜刺激征）、嵌顿＜4 小时、疝块和腹壁缺损大（没大事）

绞窄是嵌顿的晚期

4.绞窄疝（血运障碍）动脉缺血

①嵌顿疝易绞窄。但相对不易绞窄的嵌顿疝是 Richter/肠管壁疝、儿童嵌顿疝（儿童疝环较柔软）

②疼痛明显；但疼痛可暂时缓解、随后出现**继发性腹膜炎（腹膜刺激征）**、败血症

③绞窄疝急症手术：**疝囊高位结扎、但不修补**。若**肠管坏死**（肠管呈紫黑色、失去光泽和弹性、刺激后无蠕动、相应肠系膜内无动脉搏动、继发性腹膜炎、败血症）需**切除坏死肠管**

绞窄时局部肠管"很脏"，不利于修补

切开容易造成损伤，损伤会造成粘连　切开会造成壁层腹膜不完整

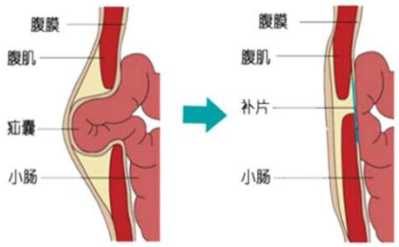
5.切口疝：经**腹直肌**切口最常见；**切口感染**是最常见原因；多为难复疝；很少嵌顿（疝环大）；疝囊多不完整

经腹直肌（除腹直肌外其他肌纤维均为横/斜向走形）纵形切口会切断很多横向纤维，形成薄弱区

切开造成的缺损较大，疝环就大，不易嵌顿

6.复发疝

真性复发疝	疝手术部位再次发生
遗留疝	手术时因疝较小被遗漏
新发疝	术后发生的疝与初次手术部位不同



（五）治疗

的斜疝和直疝

1.**保守**：＜1 岁、＜2 岁脐疝、不耐受手术（小脐没必要）

随生长发育自行消失

2.**单纯疝囊高位结扎**：＞1 岁婴幼儿、绞窄疝（结扎大一窄）

只结扎不修补　不修补原因:①没必要②修不了

3.**单纯疝修补/无张力疝修补如 Rutkow、Stoppa、Lichtenstein 法**（亚狮龙/热死了）：疼痛轻、恢复快、低复发、**最常用**（但股疝最常用 McVay 法）。但材料为异物可引起感染

传统方法

4.**疝囊高位结扎+修补**

高位结扎

传统高位结扎:把肌肉腱膜强行拉拢缝合(有张力)

加强前壁	Ferguson 法（Front）
加强后壁	①Bassini 法：最常用（BBB 话最多） ②McVay 法：**股疝**、严重薄弱者，把腹内斜肌和联合腱缝合至耻骨梳韧带（摸屁股严重可耻） ③Shouldice 法：成人的大斜疝和直疝（应该大鞋子），重点修补腹横筋膜和内环（横 S 征） ④Halsted 法

一般:缝合至腹股沟韧带

右侧中央型肺癌:横S征

5.经腹腔镜疝修补：双侧腹股沟疝尤其是多次复发或隐匿性疝

较开腹创伤小

	包块消失？	疼痛	腹膜刺激征	
易复疝	√	×	×	
难复疝	×	×	×	滑疝
嵌顿疝	×,且增大	√	×	alarm
绞窄疝	×	√,可暂时减轻 随后持续疼痛	√	